

NOTULEN

HARI / TANGGAL : MINGGU / 25 JANUARI 2026

PUKUL : 08.00 WIB

AGENDA RAPAT : RAPAT KERJA PRIMA HUSADA GRUP

PEMIMPIN RAPAT : dr. SADI HARIONO, M.MRS

NOTULIS : ADINDA LESTARI PUTRI, S.KM

TEMPAT : GOLDEN TULIP HOLLAND RESORT BATU

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Sambutan dr Sadi Hariono, M.MRS	1. Fokus di tahun 2026 harus menguatkan system 2. Buat rs center 3. Mulai koordinasikan dan konsepkan rumah sakit center yg disesuaikan dengan kebutuhan → PHS - Competitor sedikit 4. Pesan RS Prima HUsada Malang 5. Proyek di probolinggo → harapan akan naik ke tipe C 6. Proyek di Kediri →	1. Buat system yang disepakati sehingga sudah terbentuk Ketika akan di aplikasi di rumah sakit yang akan di tambahkan. System yang selalu di evaluasi dengan kesepakatan Bersama untuk di sinergikan di 4 rumah sakit 2. Rumah sakit center sehingga ada rumah sakit center yang disepakati dengan pelayanan yg lebih lengkap dan maksimal. Dan rumah sakit cabang lain bisa di rujuk ke rumah sakit center	Direksi PT, Direksi dan Manajemen Rumah Sakit

			3. PHM harus sering berkoordinasi dengan klinik agar dapat berkesinambungan 4. Proyek pengembangan di RSDH dan Kediri - RSDH → naik ke tipe C - Proses untuk merubah status menjadi rumah sakit umum → jika di biarkan akan berubah menjadi klinik utama apabila tidak segera di urus	
2.	RS Dharma Husada	1. Struktur Manajemen 2. Rekrutmen Karyawan 3. Belum muncul target strategi 4. Penguatan kebijakan di PT	1. Perlu ada pengembangan struktur manajemen → mulai kaderisasi untuk leader di rumah sakit 2. Beri kesempatan untuk staf lama yang sudah mengetahui system prima husada untuk di kaderisasi 3. Rekrutmen karyawan → Diklat grup untuk di orientasi di PT sebelum di tempatkan di masing masing unit usaha. Sehingga orientasi menyeluruh	Direksi RS, Direksi

			4. Bisa nanti disebutkn untuk targetnya agar leih jelas untuk evaluasi 5. Sebutkan strategi yang akan dilakukan dr ifit untuk meningkatkan layanan 6. Penguatan kebijakan dari seluruh sumber daya → kebijakan tentang SDM, kebijakan tentang pelayanan insurance	
3.	RS Prima Husada Malang	1. Perbaikan sarana dan fasiitas 2. Pengembanga mutu dan kebijakan Rumah Sakit 3. Penguatan Sistem 4. Gizi program klinik obesitas	1. Akan di tinjau terkait kebutuhan dan masukan dari PHM terkait sarana dan fasilitas (ruangan VIP) 2. Aktifkan Kembali program feedback ke pasienterkait pelayanan yang sudah di berikan. Bisa di adakan jabatan khusus untuk menyapa pasien dan komunikasi terkait pelayanan di rumah sakit 3. Staf lebih focus ke administrasi sehingga untuk turun ke lapangan kurang aktif, sehingga perlu built orang lapangan untuk koordinir	Direksi PT, Direksi dan Manajemen Rumah Sakit

			kondisi lapangan dan melakukan feedback ke pasien terkait pelayanan 4. Penyederhana administrasi → dibantu dengan PT untuk 3 RS harus menyederhanakan proses administrasi (de-regulasi) 5. Pemotongan regulasi dan alur untuk efisiensi dan pengurangan sistem administrasi 6. Manfaatkan tim IT yang kita punya untuk proses de-regulasi Dibantu oleh pak puguh untuk efisiensi sistem administrasi Target dari 10 menjadi 8 7. Memperkuat sistem → kelemahan dokumen tidak terecord 8. Tahun 2026 akreditasi mengejar implementasi 9. Aturan disesuaikan dengan kondisi → goal complain hilang, RS bertahan	
--	--	--	--	--

			10. Kalau membutuhkan tenaga jangan buka loker → mencari internal terlebih dahulu 11. Gizi → terkait program obesitas, kita harus menjadi contoh jangan sampai stafnya juga obesitas (role model → kebiasaan) 12. Role model diterapkan untuk all situasi tidak hanya program gizi terkait obesitas	
4.	Klinik Mutiara Sehat	1. Klinik dibangun untuk menjadi supply bagi rumah sakit 2. Penambahan Fasilitas 3. Rujukan ke Rumah Sakit 4. Peningkatan pendapatan kapitasi 5. Turn over dokter 6. Peningkatan pelayanan	1. Kenyamanan tidak berdasarkan bangunan apabila pelayanan tidak menunjang juga akan menjadi nilai keluhan dari klinik 2. Mutiara sehat harus bisa menduplikasi system prima husada terkait pengadaan obat, → seluruh vendor disamakan dengan vendor Prima Husada agar tidak beli di retail 3. Fasilitas tambahan bukan harapan tetapi nilai mutlak untuk menjadi penambahan fasilitas → bisa di	Direksi PT, Direksi PHS, Manajemen Rumah Sakit, Manajemen Klinik dan PT

			sampaikan ke PT setiap kebutuhannya 4. IKS dan rujukan di maksimalkan ke rumah sakit prima husada malang → MS sebagai penunjang RS 5. Dalam meningkatkan pendapatan kapitasi jangan hanya prolanis → ada 14 jenis pelayanan non kapitasi 6. Rujukan spesialistik dibuat indicator dengan 3 penilaian - tidak dirujuk karena ketidakpuasan - karena jarak - atau fasilitas perlu peran antara MS maupun RS untuk meningkatkan rujukan ke RS 7. Rencana perbaikan klinik MS Karangploso 8. Turn over dokter → evaluasi di lihat juga dari sisi klinik lain, apakah terjadi hal yg sama atau tidak?	
--	--	--	---	--

			9. pelayanan → kepuasan pelanggan tidak hanya diukur dari testimoni namun juga dengan hal-hal yang diukur secara acak	
5.	RS Prima Husada Sukorejo	1. Diklat terpusat 2. Peningkatan kualitas perawat 3. Kunjungan dinas luar oleh direksi PT 4. Tim 10	1. Bu Indra bisa berkontribusi langsung dengan perawat untuk keperluan Diklat → perawat bisa bekerja lebih dari itu 2. Kualitas perawat untuk PHS bisa jauh lebih baik di atas PHM dan Probolinggo → karena pemimpinnya perawat 3. Jadwalkan direksi PT bekerja di luar dengan direksi RS 4. Buat jadwal sinkron semua unit, sehingga untuk sekali dinas luar bisa all unit 5. Mulai februari ada laporan untuk Direksi PT → by group dan laporan tertulis 6. Leader bisa mulai membentuk tim 10 seperti dulu tetapi generasi baru	Direksi PT, Manajemen PT, Direksi dan Manajemen Rumah Sakit

6.	Focus Grup Discussion Kelompok 1	Kelompok Efisiensi	1. Koordinasi dengan tim HTA → tentang keluhan alat maupun ketidak efisien an alat 2. Bus MCU → buat marketing dan target untuk penggunaan MCU. 3. Gaji marketing by target 4. Buat pertemuan lagi dengan PT untuk membahas lebih lanjut program efisiensi	Direksi PT, Manajemen PT, Direksi dan Manajemen Rumah Sakit
7.	Focus Grup Discussion Kelompok 2	Klaim Paripurna	1. Kelengkapan Resume medis → breakdown lebih lanjut 2. Hasil dapat menjadi brainstorming untuk ketiga rumah sakit 3. Data 2025 tidak bisa di campur data 2026. Sehingga di 2026 memulai dari nol, tetapi tetap dengan menyelesaikan tahun 2025 → agar ada perbandingan dengan tahun sebelumnya sehingga ada 2 laporan 4. Dokter IGD → orientasi IGD di ruangan sehingga Ketika SDM merekrut sudah bisa di didik oleh manajerial terkait klaim → agar	Direksi PT, Manajemen PT, Direksi dan Manajemen Rumah Sakit

			dokter dapat lebih memahami terkait alur koding dan diagnose 5. Cara kerja verifikator di rubah untuk kerja di unit 6. Tambahkan gap masalah → perubahan klaim rawat inap ke rawat jalan, solusinya apa 7. Fragmentasinya belum muncul → munculkan agar bisa mengurangi angka sesuai indikator mutu 8. Pre coding dll dan kelengkapan klinis bukan lagi di akhir pelayanan → proyeksikan siapa yg harus di layanan untuk evaluasi dan meningkatkan klaim yg lebih baik	
8.	Focus Grup Discussion Kelompok 3	Zero Complaint	1. Tugas SDM - Harus paham visi misi untuk setiap staf yg masuk ke RS Prima Husada - Seleksi untuk orang orang yg paham terhadap etika	Direksi PT, Manajemen PT, SDM PT dan RS, Direksi dan Manajemen Rumah Sakit

			- Tahun depan untuk complain tidak mau lebih dari 10, tahun ini 315 complaint 2. Bisa di print untuk temuan complaint → taruh di ruangan terkait dan di jadikan bahan evaluasi. Ditampilkan di tempat tersembunyi untuk unit saja 3. DPJP → pendekatan terkait complain. Rapor dokter akan di aktifkan dan di masukan dalam system 4. Aplikasi dengan komite etik harus di sesuaikan dengan starkes, dan di aktifkan Kembali 5. Duplikasi untuk Mutiara sehat untuk saling berkoordinasi	
9.	Focus Grup Discussion Kelompok 4	Kelompok Pelayanan sesuai dengan PNPk	1. Buat PPK CP sesuai dengan SE dari PT 2. Lengkapi dengan harga (rupiah)	Direksi PT, Manajemen PT, Direksi dan Manajemen Rumah Sakit

10.	Sambutan Direktur Utama PT Disa Prima Medika	Rapat Kerja tahun 2026	1. Rapat Kerja tahun ini sangat berisi dan terbaik di bandingkan tahun sebelumnya 2. Target dan sistem perlu di bentuk untuk Rumah Sakit dan Klinik 3. Etika setiap rekrut staf baru maupun staf lama harus menjadi perhatian 4. Perlu memberikan pelayanan maksimal → contoh pelayanan di Golden tulip 5. Budayakan selalu memberi sebelum di minta	Seluruh unit
-----	--	------------------------	--	--------------

Mengetahui

Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Malang, 25 Januari 2026

Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Adinda Lestari Putri, S.KM

DOKUMENTASI

